



Denis Carvalho
ADVOCACIA

MATERIAL GRATUITO • DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE

7 direitos que todo **paciente e profissional da saúde** precisa conhecer

Um guia direto e atualizado sobre planos de saúde, prontuário, LGPD e a defesa de quem cuida — e de quem é cuidado.

Denis Carvalho

ADVOCACIA EM DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE

OAB/GO 53.904 — Pós-graduado em Direito Médico • Atuação em todo o Brasil

Antes de começar

A maior parte dos conflitos na área da saúde acontece por um motivo simples: as pessoas não conhecem os próprios direitos.

Pacientes aceitam negativas de planos de saúde que são, na verdade, abusivas. Médicos, dentistas e clínicas deixam de se proteger juridicamente e só procuram ajuda quando já estão diante de um processo no CRM, no CRO ou na Justiça.

Este guia reúne, em linguagem acessível, **7 direitos essenciais** — alguns voltados a quem é atendido, outros a quem atende. Conhecê-los é o primeiro passo para tomar decisões mais seguras e evitar prejuízos.

Importante: este material tem caráter exclusivamente informativo e educativo. Ele não substitui a análise de um advogado sobre o seu caso concreto, já que cada situação tem particularidades próprias.

1

Atendimento de urgência e emergência não pode ser negado

Em situações de urgência (risco imediato) ou emergência (com risco de vida ou de lesão irreparável), o plano de saúde é obrigado a garantir o atendimento. A lei estabelece um prazo de carência máximo de **apenas 24 horas** para esses casos, contados da contratação do plano.

Base: Lei nº 9.656/1998 (art. 12, V, "c") — Lei dos Planos de Saúde.

Na prática: se houver recusa ou exigência de cumprimento de carência longa em uma emergência, isso costuma ser considerado abusivo — e pode ser revertido, inclusive por decisão judicial urgente (liminar).

2

Cobertura vai além de uma lista fechada

O Rol de Procedimentos da ANS define a cobertura mínima obrigatória dos planos. Desde 2022, a lei passou a permitir, sob certos critérios (como comprovação de eficácia e recomendação técnica), a cobertura de tratamentos que não estão expressamente na lista.

Base: Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998.

Na prática: uma negativa baseada apenas em "não está no rol" nem sempre se sustenta. Tratamentos prescritos pelo médico assistente, especialmente para doenças graves, podem ter cobertura reconhecida.

3

Toda negativa deve ser por escrito e justificada

Quando o plano nega um procedimento, exame, cirurgia ou medicamento, o beneficiário tem o direito de receber a recusa **de forma clara, por escrito**, com o motivo e a cláusula contratual que a fundamenta.

Base: normas da ANS (RN nº 395/2016) e Código de Defesa do Consumidor.

Na prática: guarde protocolos, e-mails e a negativa por escrito. Essa documentação é a principal prova para contestar a recusa administrativa ou judicialmente.

4

O paciente é dono das informações do seu prontuário

O prontuário pertence ao paciente quanto ao seu conteúdo informativo. Ele tem direito de acesso e a obter cópia dos seus dados clínicos. A guarda e a confidencialidade são deveres do médico e da instituição de saúde.

Base: Resolução CFM nº 1.821/2007, Código de Ética Médica e Código de Defesa do Consumidor.

Para o profissional: manter prontuários completos, organizados e seguros é também a sua melhor defesa em eventuais questionamentos éticos ou judiciais.

5

Dados de saúde têm proteção reforçada (LGPD)

Informações de saúde são classificadas pela LGPD como **dados pessoais sensíveis**. Isso significa que seu tratamento exige base legal específica (em regra, consentimento ou tutela da saúde), finalidade definida, segurança da informação e respeito aos direitos do titular.

Base: Lei nº 13.709/2018 (LGPD), em especial o art. 11.

Para clínicas e hospitais: a adequação à LGPD não é opcional. Política de privacidade, termos de consentimento e protocolos de segurança reduzem o risco de sanções e de responsabilização.

6

Direito à informação e ao consentimento esclarecido

Antes de um procedimento, o paciente tem direito de compreender diagnóstico, riscos, benefícios e alternativas, e de decidir livremente. Esse é o chamado consentimento livre e esclarecido.

Base: Código de Ética Médica e legislação de defesa do consumidor.

Para o profissional: um Termo de Consentimento bem elaborado, específico para cada procedimento, protege a relação e demonstra a transparência da conduta.

7

Direito de defesa nos conselhos (CRM / CRO)

Profissionais da saúde que recebem uma notificação, sindicância ou processo ético-disciplinar têm direito ao contraditório e à ampla defesa. Uma resposta técnica e bem fundamentada, desde o primeiro momento, faz diferença no resultado.

Base: Constituição Federal (art. 5º, LV) e códigos de processo ético dos conselhos profissionais.

Na prática: o erro mais comum é responder a uma notificação do conselho sem orientação jurídica. A defesa inicial costuma ser decisiva — não deixe para depois.

Conhecer o direito é o começo. Exercê-lo é o que muda o resultado.

Se você se identificou com alguma dessas situações — como paciente, médico, dentista, clínica ou hospital — uma orientação jurídica especializada pode esclarecer o seu caso e indicar o melhor caminho.

Fale com um **advogado especializado**

Atendimento humanizado em Direito Médico e da Saúde, com atuação em todo o Brasil. Tire suas dúvidas sem compromisso.

WhatsApp (62) 99258-6422

Site deniscarvalhoadvocacia.com

E-mail contato@deniscarvalhoadvocacia.com.br

Instagram [@deniscarvalho.advogado](https://www.instagram.com/deniscarvalho.advogado)

Aviso legal. Este e-book tem finalidade meramente informativa e educativa, em conformidade com o Código de Ética e Disciplina da OAB e o Provimento nº 205/2021. Não constitui consulta, parecer ou aconselhamento jurídico individual, não promete resultados e não configura oferta de serviços ou captação de clientela. As referências legislativas podem sofrer alterações; consulte sempre um(a) advogado(a) para a análise do seu caso concreto.

© Denis Carvalho Advocacia — Todos os direitos reservados.